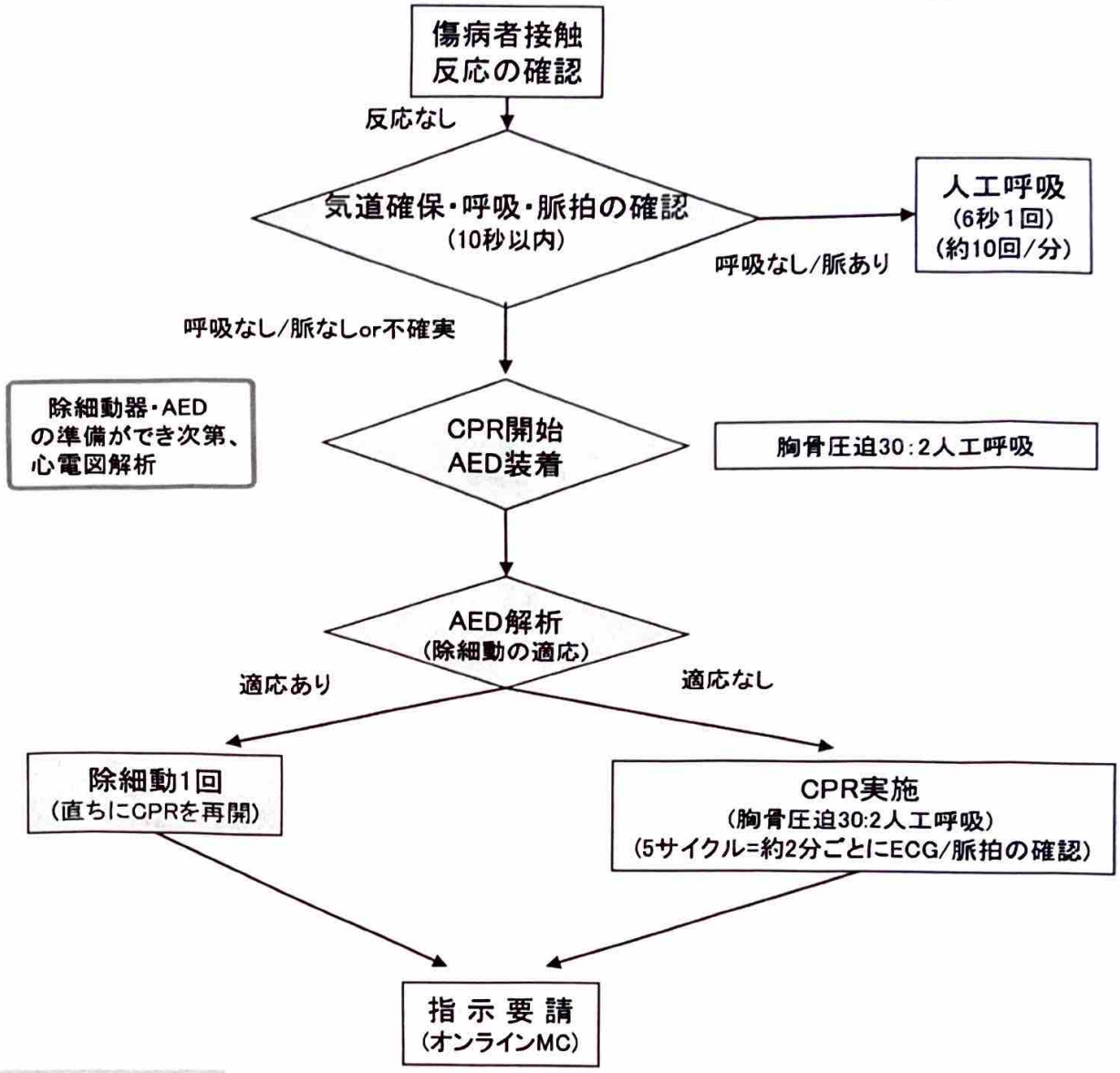
CPA（AED）事例対応　アルゴリズム

BANDO-MC協議会
指示指導部会
Ver.240901

事前情報がCPAであっても、なくても現場(接触時)にはAEDを持参する



救急隊（救命士）

指導医と連絡とれれば指導医の指示に従う
- 器具を用いた気道確保
- 静脈路確保
- 薬剤投与

（気管挿管は救命救急センターに指示要請）

指導医の指示が得られなければ
1) 救命士が除細動適応あると判断すれば、現場で除細動＋CPRは3サイクルまで可
2) 適応なくなれば現発

指導医の選定
特定行為の指示
・BANDO-MC参加医療機関の医師から受ける

先着消防隊

指導医と連絡とれれば指導医の指示に従う

指導医の指示が得られなければ
・AED解析で除細動適応あると判断されれば、CPR＋除細動

搬送先の選定基準

・救急搬送基準に基づき選定する
（地域医療体制を考慮する）

<< 言葉の意味 >>

意識回復の可能性高い事例の要件
・ 目撃あり、あるいは「目撃あり」に近いと判断されている
・ bystander CPRが行なわれている
・ 接触時モニターで VF/VTである【救急隊】か、AEDで除細動の適応ありと判断された【先着消防隊】
・ 現場CPRを実施していてモニターでVF/VTとなった【救急隊】、あるいはAEDで除細動の適応となった【先着消防隊】
・ 上記のいずれかが該当する場合

意識回復の可能性が低い事例の要件
・ 目撃がなく（倒れているのが発見され、何時倒れたかわからない）
・ なおかつ、接触時モニターでAsystole【救急隊】（AEDで除細動の適応なし【先着消防隊】）で現場でCPRを実施後の解析でもAsystole【救急隊】(AEDで除細動の適応なし【先着消防隊】)が持続している
・ なおかつ、寒冷に曝されるなど低体温が原因とは考えられない場合

〇上記以外は現在のところ、「意識回復の可能性高い事例」として扱うことにする(PEAなどが含まれる)

[目撃あり]
心停止の瞬間を目撃することで、具体的には目の前で意識を消失するのを目撃した場合で倒れる瞬間を目撃していることを意味する。倒れる音を聞いて駆けつけた場合などは含まないが、「目撃あり」に近い事例として評価する。

[バイスタンダーCPR]
「目撃あり」の後に引き続いて行われているCPRで、胸骨圧迫のみでもよい。目撃のないCPAではバイスタンダーCPRはあり得ない。目撃がありながら胸骨圧迫まで数分以上放置されればバイスタンダーCPRありとは言えないが、事実上確認することができなければバイスタンダーCPRありと判定する。

[胸骨圧迫、人工呼吸の数え方]
胸骨圧迫 30 : 人工呼吸 2 ＝ 1サイクル
1サイクル × 5 （5サイクル）≒ 2分
5サイクル ＝ 1クール

質の高いCPR（基本目標）
・圧迫の速さは100～120回/分
・圧迫の深さは約5cm
・圧迫毎に力を抜き胸壁を完全に元の位置に戻す
・胸骨圧迫の中断は10秒以内
・過換気を避ける